19.2.2
Demenz

Pina im Praxiseinsatz

Während ihres Praktikums in der Neurologie betritt Pina gemeinsam mit ihrer anleitenden Fachkraft das Zimmer einer 85-jährigen zu Pflegenden. Die alte Dame sitzt am Tisch, schaut kurz auf und erklärt dann, dass sie jetzt gar keine Zeit habe, weil sie auf den Besuch ihrer Mutter warte. Sie sollten jetzt gehen und sie in Ruhe lassen. Die anleitende Fachkraft spricht kurz, ruhig und freundlich mit der zu Pflegenden. Nach Verlassen des Zimmers erfährt Pina von ihrer Pflegeanleitung, dass die Dame an einer Demenz im fortgeschrittenen Stadium leidet.

DEFINITION

Demenz ist eine organisch bedingte, erworbene und über Monate bis Jahre zunehmende degenerative (abbauende) Veränderung des Gehirns, die durch den Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit, durch Defizite im Verhalten und durch Probleme bei der Alltagsbewältigung gekennzeichnet ist. Die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter. Trotzdem ist die Demenz keine „normale Alterserscheinung", sondern eine Erkrankung.

KINDER UND JUGENDLICHE

Eine Demenz auch im Kindes- und Jugendalter zu entwickeln ist grundsätzlich möglich. Es gibt angeborene und genetisch bedingte Stoffwechselerkrankungen, bei denen sich verschiedene Stoffwechselprodukte im Gehirn ablagern und Nervenzellen zerstören. Diese können auch im Kindesalter zum Abbau der geistigen Entwicklung und der Lernfähigkeit führen. Ebenso können Entzündungsprozesse und Verletzungen im Gehirn auch im Kindes- und Jugendalter zu einem Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit führen. Weiterhin gibt es angeborene Syndrome, die eine geistige Behinderung als Symptom beinhalten und die Entwicklung der geistigen Leistungsfähigkeit begrenzen.

Pathogenese

Die Alzheimer-Demenz und die vaskuläre Demenz sind die am häufigsten auftretenden Formen der Demenz.

1. **Alzheimer-Demenz:** Hier entstehen Ablagerungen von krankhaften Eiweißen (Plaques), die nach und nach die Nervenzellen im Gehirn zerstören.
2. **Vaskuläre Demenz:** Hier besteht der Grund für die Demenz in einer Veränderung der Blutgefäße im Gehirn (vaskulär bedeutet „die Gefäße betreffend"). Hier ist eine Arterienverkalkung (Arteriosklerose) im Bereich der Gehirngefäße und die damit verbundene schlechte Durchblutung und Unterversorgung mit Sauerstoff der Grund für die Demenz.

Symptome

- **Gedächtnisstörungen:** Schwierigkeiten, neue Informationen aufzunehmen
- **Denkstörungen:** Konzentration und Informationsverarbeitung zunehmend gestört

• **Affektive Störungen:** stark wechselnde Gefühlsäußerungen in kürzester Zeit
• **Antriebsstörungen:** eingeengter Lebensraum und abnehmende soziale Kontakte
• **Neuropsychologische Symptome:** Verlust der Fähigkeit, bestimmte Handlungen auszuführen, die zuvor beherrscht wurden
• **Psychomotorische Störungen:** reduzierte Mimik, Gestik, Sprache und Bewegung

Schweregrade einer Demenz

• **Leichte Demenz:** Störungen des Kurzzeitgedächtnisses (Probleme, sich neue Information zu merken), Wortfindungsstörungen und Schwierigkeiten bei der Orientierung in fremder Umgebung; die Persönlichkeit der Betroffenen als auch die Orientierung in vertrauter Umgebung bleiben erhalten.
• **Mittelgradige Demenz:** Hier ist zunehmend auch das Langzeitgedächtnis (Erinnerung an länger zurückliegende Ereignisse) betroffen. Es kommt zu Problemen, sich in vertrauter Umgebung zurechtzufinden, auch vertraute Personen werden nicht mehr erkannt oder verwechselt. Die Bewältigung des Alltags ist sehr erschwert. Die Betroffenen sind unruhig und umtriebig (ungezieltes Herumirren). Die Notwendigkeit von Hilfe und Aufsicht beginnt.
• **Schwere Demenz:** In diesem Stadium ist Hilfe bei allen Aktivitäten des täglichen Lebens nötig. Die Betroffenen sprechen und bewegen sich immer weniger. Die Betroffenen werden immer hilfloser und pflegebedürftiger bei starkem Verlust der Persönlichkeit.

Die einzelnen Demenzstufen lassen sich nicht scharf voneinander trennen, sondern gehen meist fließend ineinander über.

Diagnostik

Eine Anamnese, besonders auch eine Fremdanamnese (Angehörige, Bekannte oder sonstige Dritte machen Angaben zum Krankheitsgeschehen), Blutuntersuchungen, technische Untersuchungen (CT oder MRT) und psychometrische Test werden durchgeführt.

Ein bekannter und schnell durchzuführender psychometrischer Test ist der **Uhrentest .** Hierbei sollen in einen vorgezeichneten Kreis die Ziffern 1–12 eingetragen und dann eine bestimmte Uhrzeit mit Uhrenzeigern eingezeichnet werden. Je fehlerhafter die Ziffern, der Uhrenzeiger und die Uhrzeit eingezeichnet werden können, desto höher ist die Gefahr, an einer Demenz erkrankt zu sein.

Sehr häufig wird als psychometrischer Test auch der **Mini-Mental-Status-Test (MMST)** durchgeführt. Hier werden Aufgaben zur räumlichen Orientierung, zur Merkfähigkeit, zur Erinnerungsfähigkeit, zur Aufmerksamkeit, Rechenfähigkeit und Sprache gestellt. Die Durchführung des MMST dauert 10–15 Minuten.

Therapie

MERKE

Eine Therapie, die die Ursachen einer Demenz bekämpft, gibt es bis heute nicht. Ziel der Behandlungsstrategie ist es, Betroffene zu geistigen und körperlichen Anstrengungen zu motivieren, sie kognitiv anzuregen, ihre geistigen und sozialen Fähigkeiten zu fördern und ein Mindestmaß an alltagspraktischen Fähigkeiten möglichst lange zu erhalten. Alle Angebote müssen individuell an die zu Pflegenden angepasst werden.

Medikamentöse Therapie

Medikamentös stehen Antidementiva zur Verfügung, die aber das Fortschreiten einer Demenz weder stoppen noch eine Demenz heilen können. Weiterhin können Medikamente wie z. B. Antidepressiva, Neuroleptika (bei Verhaltensstörungen wie Aggressivität, Unruhe und Umtriebigkeit) und Schlafmittel verordnet werden.

Pflege

Pina im Praxiseinsatz

Wie Pina lernt, ist die Pflege von Demenzkranken immer eine individuelle Pflege und muss an jeden zu Pflegenden und dessen Krankheitsverlauf angepasst werden.

MERKE

Pina hat erlebt, dass der Umgang mit an Demenz Erkrankten viel Geduld und Einfühlungsvermögen erfordert und eine große Herausforderung für alle Pflegenden ist. Die Aufgabe der Pflegenden ist es, die aktuelle Situation der Betroffenen als Gesamtbild zu erfassen. Dazu benötigen die Pflegenden Wissen über die Biografie (➤ Kap. 4.1.3) und über persönliche Erfahrungen und Vorlieben der Betroffenen. Gerade für desorientierte zu Pflegende ist eine feste Bezugsperson sehr wichtig. Die Beziehungsgestaltung als Bezugspflege (➤ Kap. 4.2.1) steht hierbei im Mittelpunkt.

Menschen mit Demenz reagieren auf ihre Umwelt mit Unsicherheit und Angst, weil sie Dinge und Ereignisse falsch einordnen und deshalb Angst entwickeln. Sie bekommen viele Informationen, die sie nicht verstehen, und bringen Vergangenheit und Gegenwart durcheinander.

Menschen mit Demenz zeigen Verhaltensweisen wie zielloses Herumwandern, Schreien und permanentes Rufen, Schlafstörungen und Teilnahmslosigkeit (Apathie).

Die Pflege des an Demenz erkrankten Menschen ist weniger vom Typ der Demenz als vielmehr vom jeweiligen Stadium abhängig, in dem sich die zu Pflegenden befinden. Je fortgeschrittener die Erkrankung ist, desto mehr Unterstützung benötigen die Betroffenen bei allen alltäglichen Verrichtungen. Es gelten alle Maßnahmen der Grundpflege (Körperpflege, Ernährung und Mobilität) sowie der Prophylaxe, z. B. Dekubitus, Pneumonie, Thrombose, Soor und Parotitis, Intertrigo, Obstipation und Sturz (➤ Kap. 11).

Körper- und Kleiderpflege und Körpertemperatur

• Soviel Selbstständigkeit wie möglich und nur so viel Unterstützung wie nötig, z. B. durch Bereitlegen von Utensilien zur Körperpflege oder Kleidung in der richtigen Reihenfolge, durch konkrete verbale Anleitung oder durch „Vormachen“ der Handlung.
• Auf angemessene Bekleidung der vom Betroffenen gewählten Kleidung achten, falls die zu Pflegenden eine Bekleidung auswählen, die der Außentemperatur unangemessen ist.
• Schuhe und Kleidung sollten so gewählt werden, dass sie zusätzlich der Sturzprophylaxe dienen.

Ernährung

• Nahrungs- und Getränkeaufnahme kontrollieren, ggf. die Nahrung mundgerecht vorbereiten und Essen und Getränke anreichen.
• Den zu Pflegenden im Tagesverlauf häufiger Getränke anbieten, um eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu gewährleisten.
• Sich bei Angehörigen nach den Lieblingsgetränken und dem Lieblingsessen der Betroffenen erkundigen.

Ausscheidung

Durch aktivierende Pflege (➤ Kap. 4) kann gut Sorge dafür getragen werden, dass die zu Pflegenden den Toilettengang nicht vergessen und rechtzeitig zur Toilette gehen, falls der Weg zur Toilette weit ist und/oder die Betroffenen sich nur noch langsam fortbewegen können

Bewegung

• Betroffene zu Bewegung animieren, aber dabei für Sicherheit sorgen, damit die zu Pflegenden z. B. durch einen Sturz keinen Schaden erleiden.
• Die Umgebung sicher gestalten (scharfe Gegenstände, Streichhölzer, Feuerzeuge, Haushaltschemikalien, Elektrogeräte entfernen oder sichern).

Unruhe

• Aufgeregten, schimpfenden, laut rufenden und ziellos herumirrenden Betroffenen mit Ruhe und Sicherheit begegnen und eine Geborgenheit vermittelnde Atmosphäre schaffen.
• Bei großer Unruhe die Energien umleiten, z. B. durch Spaziergänge und Beschäftigung.

Kommunikation

• Den Menschen immer ernst nehmen und ihm mit Würde und Respekt begegnen – das sprachliche Niveau beachten (keine Kindersprache).
• Persönliche Ansprache – Namen benutzen.
• Viel Zeit nehmen, damit Gesprochenes verstanden wird.
• Körpersprache bewusst einsetzen – sicht- und spürbar bleiben durch Blickkontakt, Berührungen, eindeutige Gestik und Mimik.
• Vereinfachte Sätze verwenden, keine oder wenige Nebensätze, kurze Kommandos.
• W-Fragen stellen, um Fakten zu erfahren – wer, was, wann, wie; aber niemals warum.
• Langsam, laut und deutlich sprechen – aber nicht zu laut.
• Über emotional Positives Sprechen.
• Sich immer auf die Realität des Betroffenen einlassen und ihm nicht zwanghaft vermitteln, dass z. B. der Ehemann nicht mehr lebt oder man sich nicht an einem bestimmten Ort befindet.
• Ganz viel Geduld mitbringen.

Denkstörungen und Merkfähigkeitsstörungen

• Ruhig zuhören und ausreden lassen.
• Nicht ins Wort fallen und ausreden lassen.
• Zum besseren Verständnis nachfragen, das Gesagte wiederholen und vom zu Pflegenden bestätigen lassen.
• Notizzettel oder Tagesplan dort anbringen, wo sie benötigt werden (z. B. am Badezimmerspiegel).
• Notizbuch, in das die zu Pflegenden Eintragungen zur Erinnerung hineinschreiben können, anschaffen.

Antriebsstörungen

• Teilnahmslosigkeit durchbrechen durch Gespräche bei der täglichen Körperpflege oder durch eigene Erzählungen.
• Gemeinsames Singen, Karten- und Gesellschaftsspiele und Bewegungsgruppen als Stationsprogramm.

Schlaf

• Bei gestörtem Schlaf-Wach-Rhythmus und großer Nachtaktivität den Tagesablauf strukturieren und den Tagschlaf durch Beschäftigungsangebote (besonders Beschäftigungsangebote in den Abendstunden) reduzieren.
• Ruhige Gespräche und Halten der Hand bei Unruhe und Angst als Hilfe beim Einschlafen zur Nachtruhe.

MITDENKEN

Pina lernt verschiedene Konzepte bei der Betreuung von an Demenz erkrankten Menschen kennen. Alle Pflegekonzepte beruhen darauf, den Betroffenen mit Wertschätzung, Akzeptanz und Geduld zu begegnen, mit ihnen eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und dabei ihre Individualität und ihre Biografie, also ihr gelebtes Leben, zu berücksichtigen und sie als Menschen wahrzunehmen.

Zum Weiterlesen empfehlen sich „Der Personenzentrierte Ansatz nach Tom Kitwood“ und die Methode der „Validation“ nach Naomi Feil.

Die 10-Minuten-Aktivierung von Uta Schmidt-Hackenberg möchte an Demenz erkrankte Menschen im Tagesverlauf aktivieren. In kleinen, homogenen Gruppen wird mit Alltagsgegenständen oder Materialien gearbeitet, die die Betroffenen von früher kennen und über die sie sich gemeinsam austauschen können (z. B. Haushaltsgegenstände, Handwerksgegenstände, verschiedene Kleidungsstücke, Bilder, Bücher, alte Zeitungen).